

ΟΞΕΙΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΔΑ

Γενικά: Ως οξεία παγκρεατίτιδα (ΟΠ) χαρακτηρίζεται η οξεία καταστροφή του παγκρέατος λόγω ενεργοποίησης των παγκρεατικών ενζύμων, με δημιουργία τοπικής και στις βαρειές περιπτώσεις συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης (SIRS). Η ταξινόμηση της Atlanta κατηγοριοποιεί την ΟΠ σε δύο ομάδες: τη **διάμεση οιδηματώδη οξεία παγκρεατίτιδα** και τη **νεκρωτική οξεία παγκρεατίτιδα**. Η πρώτη κατηγορία χαρακτηρίζεται από παγκρεατική παρεγχυματική και περιπαγκρεατική φλεγμονή χωρίς νέκρωση, ενώ η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει φλεγμονή και ορισμένου βαθμού νέκρωση. Συνηθέστερα αίτια ΟΠ είναι η χολολιθίαση (40-70%) και η κατάχρηση αλκοόλ (25-35%). Η ΟΠ που οφείλεται σε λιθίαση είναι ένα οξύ περιστατικό, το οποίο λύεται όταν ο χολόλιθος αφαιρεθεί ή διέλθει αυτόματα. Η πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής υπερτριγλυκεριδαμία αποτελεί, επίσης, το αίτιο στο 1-4% των περιπτώσεων ΟΠ (*TRG ορού* > 1000 mg/dl). Λιγότερο συνήθη αίτια αποτελούν οι όγκοι που αποφράσσουν τον παγκρεατικό πόρο, λοιμώδεις παράγοντες, φάρμακα, τοξίνες, καθώς και μεταβολικά αίτια, όπως απεικονίζονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα:

➤ Χολολιθίαση (Ελλάδα: 70%, Ευρώπη: 35-40%). ➤ Αλκοολική (Ελλάδα: 6%, Ευρώπη: 25-30%). ➤ Υπερτριγλυκεριδαμία (ή <i>Χυλομικροναμία</i>). ➤ Ιδιοπαθής. ➤ Τραύμα (διατιτραίνον κοιλιακό τραύμα). ➤ Κάπνισμα (δοσοεξαρτώμενη συσχέτιση). ➤ Υπερασβεστιαμία (επί PHPT: 1,5-7%). ➤ Φάρμακα (Azathioprine, Sulfonamides, 5-ASA, HCTZ, Furosemide, Tetracycline, Valproic acid, Didanosine, Methyldopa, NSAIDs, Estrogens, PPIs, 6-Mercaptopurine, Pentamidine, Corticosteroids, Octreotide, GLP-1, Macrolides, Fibrates, SSRIs). ➤ Τοξίνες (νυγμός σκορπιού, οργανοφωσφορικά). ➤ Μετά από ERCP ή κοιλιακό χειρουργείο.	➤ Δυσλειτουργία του σφιγκτήρα Oddi. ➤ Αυτοάνοση ΟΠ τύπου I (LPSP/Systemic IgG4 disease-related) και τύπου II (IDCP). ➤ Ιογενής (Coxsackie, CMV, EBV, VZV, Echovirus, Hepatitis A/B/C, HIV, Mumps, Rubella). ➤ Βακτηριακή (<i>C. jejuni</i>, <i>Legionella</i>, <i>Leptospirosis</i>, <i>Mycoplasma</i>, <i>M. avium</i>, <i>M. tuberculosis</i>). ➤ Παρασιτικές λοιμώξεις (<i>Ascaris lumbricoides</i>, <i>Clonorchis sinensis</i>, <i>Plasmodium falciparum</i>, <i>Cryptosporidium</i>, <i>Microsporidia</i>). ➤ Συγγενείς ανωμαλίες (δακτυλ/δές πάγκρεας). ➤ Γενετικές ανωμαλίες (κυστική ίνωση, έλλειψη της α1 αντιθρυψίνης, μετάλλαξη γονιδίου PRSS1). ➤ Χρόνια νεφρική νόσος (αιμοδιάλυση). ➤ Αγγειίτιδες (οξώδης πολυαρτηρίτιδα, ΣΕΛ).
--	---

Η ΟΠ ευθύνεται για το 3% των περιπτώσεων οξείας κοιλίας και αποτελεί σοβαρή πάθηση, με θνητότητα που κυμαίνεται στο 3-8%, παρά την πρόοδο στη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Κλινική εικόνα: Ο ασθενής περιγράφει συνήθως μέτριο έως έντονο κοιλιακό άλγος, με ευαισθησία στο επιγάστριο, ακαμψία κοιλιακών τοιχωμάτων, ανορεξία, ναυτία, τάση προς έμετο, μετεωρισμό και μειωμένους εντερικούς ήχους. Το άλγος μπορεί να ανακουφίζεται μερικώς στην καθεστηκία θέση, λόγω της οπισθοπεριτοναϊκής θέσεως του παγκρέατος. Η φύση του πόνου μπορεί να ποικίλλει, αναλόγως εάν η αιτία αφορά σε απόφραξη ή είναι μεταβολική/τοξική. Επί λιθιασικής ΟΠ ο πόνος περιγράφεται συχνότερα ως πιο οξύς, με αιφνίδια έναρξη, ο οποίος ακτινοβολεί στην πλάτη και την οσφύ. Ενώ, επί μεταβολικών ή τοξικών αιτίων (π.χ. αλκοόλ, φάρμακα, κ.ά.) ο πόνος έχει συχνά σταδιακή εμφάνιση με αμβλύ, αλλά γενικευμένο χαρακτήρα. Επίσης, παρατηρείται δεκατική τυρετική κίνηση ή τυρετός (σπάνια) και ταχυκαρδία. Η παρουσία τυρετού με ή χωρίς ρίγος με την εμφάνιση της ΟΠ πρέπει να εγείρει την υποψία συνοδού χολαγγειίτιδας. Σε βαρειές περιπτώσεις - λόγω υποογκαιμίας από απώλεια υγρών στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο και αγγειοδιαστολή/αυξημένη αγγειακή διαπερατότητα - μπορεί να εμφανιστεί υπόταση ή/και καταπληξία ή/και ολιγουρία. Σε σοβαρές περιπτώσεις ΟΠ, με συνοδό οπισθοπεριτοναϊκή αιμορραγία, μπορεί να εμφανιστούν: το σημείο Grey-Turner (εκχύμωση στην πλάγια κοιλία), το σημείο Cullen (περιομφαλική εκχύμωση), το σημείο Fox (βουβωνική εκχύμωση), (βλ. επίσης σελ. 230).

Παρακλινικές εξετάσεις: Διενεργούμε γενική αίματος (WBC) και B/X έλεγχο (γλυκόζη, ουρία, κρεατινίνη, $K^+/Na^+/Ca^{++}$, CRP, AST/ALT, αμυλάση ορού, αμυλάση ούρων, Bil (t/d), γ-GT, ALP, LDH, TRG) ή/και αέρια αρτηριακού αίματος (εφόσον έχουμε τη δυνατότητα) για έλεγχο των μεταβολικών διαταραχών που ευθύνονται για την ΟΠ ή είναι απότοκα αυτής.

Η διάγνωση της ΟΠ βασίζεται στον συνδυασμό της κλινικής εικόνας, της αυξημένης τιμής Αμυλάσης (ορού & ούρων) και Λιπάσης και των ευρημάτων από τον απεικονιστικό έλεγχο (U/S παγκρέατος/ήπατος/χοληφόρων, ERCP/MRCP και CT κοιλίας). Συνήθως, εμφανίζεται 10πλάσια αύξηση της αμυλάσης του ορού και των ούρων (απαραιτήτως για τη διάγνωση απαιτείται 3πλάσια της ανώτερης φυσιολογικής τιμής). Η αμυλάση ορού αυξάνεται το πρώτο 24ωρο και σταδιακά μειώνεται μετά από 2-3 ημέρες επί αυτοπεριοριζόμενης νόσου, ενώ η αύξηση κι αντίστοιχα η πτώση της αμυλάσης των ούρων ακολουθεί. Στην ΠΦΥ, κρίνονται απαραίτητες η ακτινογραφία θώρακος (F/P) και η ακτινογραφία κοιλίας σε όρθια θέση.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Η αντιμετώπιση του ασθενούς, που έρχεται ή διακομίζεται στο ΤΕΠ με εικόνα ΟΠ, επιτελείται παράλληλα με την κλινική και εργαστηριακή διερεύνηση. Έτσι, σε ασθενή με βαριά ΟΠ, σε κοματώδη κατάσταση, αξιολογούνται αρχικώς τα Α, Β, C, D, E και διενεργούμε νευρολογική εξέταση, ελέγχοντας το επίπεδο συνείδησης (GCS ή AVPU).
2. Μεριμνούμε για επαρκή οξυγόνωση του ασθενούς, ώστε να διατηρείται $SpO_2 > 90-92\%$, χορηγώντας O_2 στα 4-8 lt/min, με απλή μάσκα οξυγόνου ή με μάσκα Venturi (24-31%).
3. Τοποθετείται 3way φλεβική γραμμή μεγάλου εύρους (#16-18G) και στα δύο άνω άκρα.
4. Λαμβάνονται αίμα και ούρα για εργαστηριακό έλεγχο. Εκτελείται ΗΚΓ και ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (ΑΠ, HR, RR, SpO_2 , $\theta^\circ C$), καθώς και άμεσα τα επίπεδα γλυκόζης με Dextro-stick, ενώ προγραμματίζεται ο ασθενής για απεικονιστικό έλεγχο.
5. Πυλώνας της αντιμετώπισης της ΟΠ παραμένει η πρώιμη και επιθετική αναζωογόνηση με υγρά. Αρχικώς, χορηγούνται κρυσταλλοειδή, ήτοι: 1 lt R/L ή R/S, αναλόγως της ΑΠ. Το διάλυμα R/L είναι το συνιστώμενο, με αρχική δόση 15-20 ml/kg ΒΣ και ακολούθως σε δόση 3 ml/kg ΒΣ ανά ώρα (συνήθως 250-500 ml ανά ώρα) για τις πρώτες 24 ώρες, εάν δεν υπάρχουν άλλες αντενδείξεις ή αναλόγως της βαρύτητας της ΟΠ (βλ. σελ. 230).
6. Επί έντονου κοιλιακού άλγους, με συνοδά επεισόδια ναυτίας και εμέτων, χορηγούμε 1-2 amp. Σιμετιδίνη (Tagamet) και 1 amp. PPI, μαζί με 1 amp. Primperan σε 100 ml N/S. Σε εμμένουσα έμεση μπορεί να χορηγηθεί 1 amp. Ondansetron 4 mg σε 100 ml N/S (iv).
7. Εφόσον το κοιλιακό άλγος είναι έντονο και διάχυτο, επιδεινούμενο και μη ανεκτό πλέον από τον ασθενή, χορηγούνται αναλγητικά. Τοποθετούμε 1 fl. 100 ml Παρακεταμόλη 1 gr (Apotel), ώστε να χορηγηθούν εντός 15-20 λεπτών. Σε επιμονή ή επίταση του πόνου, μετά παρέλευσης 20-30 λεπτών ή ευθύς εξαρχής, χορηγούμε 1 amp. Τραμαδόλη 100 mg (Tramal) σε 100 ml NaCl 0,9% εντός 20-30 λεπτών (iv) ή αλλιώς 1 amp. Πεθιδίνη (im) ή 1 amp. Δεξτροπροποξυφαίνη 75 mg (Romidon / Zideron) (im).
8. Επί ναυτίας ή εμέτων ή σε περίπτωση πάρεσης εντέρου, συστήνεται ουδέν per os (NPO) και τοποθετούμε ρινογαστρικό σωλήνα Levin για κένωση κι ανακούφιση του στομάχου.
9. Τοποθετείται καθετήρας Foley (14-16 fr), προς αποσυμφόρηση της ουροδόχου κύστεως, καθώς και για τη μέτρηση των ούρων, που πρέπει να κυμαίνονται στα 4-6 ml/kg/h.
10. Εφόσον μετρηθούν τα αέρια αρτηριακού αίματος, τότε στους ασθενείς με βαριά οξέωση (δηλ. με $pH < 7,1$) και ειδικά σε αυτούς με χρόνια νεφρική νόσο, μπορεί να χορηγηθούν Διττανθρακικά. Έτσι, διαλύουμε 1-2 amp. Διττανθρακικό Νάτριο 4% ($NaHCO_3$) σε ορό 100-250 ml NaCl 0,9% (1 amp. 4% περιέχει 400 mg ή 4,8 mEq $NaHCO_3$) και χορηγούμε εντός διαστήματος 30-45 λεπτών ή μέχρι τη διακομιδή του ασθενούς στο νοσοκομείο.
11. Σε περιπτώσεις έντονης ψυχοκινητικής διέγερσης εξαιτίας του άλγους, επιχειρούμε ήπια καταστολή (εφόσον δεν έχουν ήδη χορηγηθεί οπιοειδή ως αναλγητικά), με χορήγηση ενδοφλεβίως 1 amp. Διαζεπάμης 10 mg (Stedon), σε 100 ml N/S, εντός 20-30 λεπτών.
12. Δεν απαιτείται προφυλακτική χρήση αντιβιοτικών. Επί υποψίας λοίμωξης, η εμπειρική αντιβιοτική αγωγή κρίνεται επαρκής μέχρι να ληφθεί το αποτέλεσμα των καλλιιεργειών.
13. Άμεση διακομιδή στο νοσοκομείο, συνοδεία ιατρού, υπό συνεχές monitoring (ΗΚΓ, ΑΠ, σφύξεις, RR, SpO_2 , διούρησης), για περαιτέρω αντιμετώπιση και κλινική διερεύνηση.